

RECURSO CÍVEL Nº 5064367-36.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES
RECORRENTE: ANDERSON WAGNER SILVA DE CARVALHO (AUTOR)
RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)
RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. DIABETES (DM2) E OBESIDADE. MEDICAMENTO SEMAGLUTIDA (OZEMPIC). PERDA DE PESO. USO OFF LABEL. PARECER DO NAT. REVISÃO SISTEMÁTICA VERIFICOU A EFICÁCIA E SEGURANÇA DE TAL MEDICAMENTO PARA CONTROLE DE PESO CRÔNICO. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO COMPROVADA. ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS ESGOTADAS. TEMA 793 OBSERVADO. PRECEDENTE DA TURMA Nº: 5013887-54.2024.4.02.5101. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido de caráter definitivo e determinar que as Rés, solidariamente, conforme suas respectivas atribuições fixadas pelo SUS (Tema 793 do STF e Lei nº 8.080/90), forneçam à parte autora a medicação SEMAGLUTIDA, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 60 (trinta) dias a contar da intimação desta decisão, de forma contínua e ininterrupta, observando-se o que se segue: (i) A medicação em questão deverá ser entregue em local a ser indicado pelos réus, dentro do prazo para cumprimento, a fim de que a parte autora ou seu representante legal possam nele comparecer, para procederem à retirada da medicação requisitada. (ii) A entrega à parte autora da referida medicação, em qualquer hipótese, deverá ser necessariamente confirmada pelos réus, nos autos, sob pena de se entender sua omissão como descumprimento desta sentença e conseqüente sequestro de verba pública para aquisição da mesma. (iii) Determino, ainda, que a parte autora apresente requerimento com nova prescrição médica, quando da necessidade de reposição dos medicamentos fornecidos ou de troca de medicação, bem como que informe, em nome da lealdade processual, caso não necessite mais da medicação aqui requerida. Deverá, também, informar nestes autos eventual mudança de endereço. (iv) Nesse sentido, destaque-se que, sempre que for requerido pelos réus, deverá a parte autora apresentar-lhes, diretamente nos órgãos de execução do fornecimento da medicação em apreço, receituário atualizado e demais dados e documentos que se mostrarem necessários, a fim de que os réus procedam ao controle do fornecimento ora deferido. Sem custas e honorários. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de março de 2025.

5064367-36.2024.4.02.5101

510015603445 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5064367-36.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES
RECORRENTE: ANDERSON WAGNER SILVA DE CARVALHO (AUTOR)
RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)
RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte Autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento, nos seguintes termos:

"ANDERSON WAGNER SILVA DE CARVALHO propõe a presente demanda, pelo rito dos Juizados Especiais Federais, com pedido de antecipação de tutela e provimento final, por meio da qual a parte autora, portador de diabetes mellitus insulino-dependente e obesidade, requer a

condenação da União Federal, do Estado do Rio de Janeiro e do Município do Rio de Janeiro, em responsabilidade solidária, na obrigação de fornecerem o medicamento Semaglutida (Ozempic), pelo tempo que durar seu tratamento, de acordo com as suas necessidades clínicas.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1º da Lei 10.259/01.

Passo a decidir.

DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO

Inicialmente, de acordo com a documentação médica que instrui a exordial, verifico que o autor apresenta diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2, obesidade e síndrome metabólica. Informa-se, também, que já fez uso de diversos medicamentos - metformina (Glifage®), glibenclamida, insulina NPH, insulina regular, insulina glargina, empagliflozina, linagliptina, liraglutida (Victoza®), dapagliflozina (Forxifa®) - todos sem sucesso. Assim, apresenta indicação para tratamento com o medicamento Semaglutida 1mg (Ozempic®).

Acerca do referido fármaco, esclarece-se que possui indicação em bula no tratamento do quadro clínico de diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Contudo, para o quadro de obesidade, não há indicação em bula, portanto seu uso seria off label.

Nesse aspecto, o órgão técnico esclarece o seguinte:

"O uso off-label de um medicamento significa que o mesmo ainda não foi autorizado por uma agência reguladora, para o tratamento de determinada patologia. Entretanto, isso não implica que seja incorreto. Pode ainda estar sendo estudado, ou em fase de aprovação pela agência reguladora. Em geral, esse tipo de prescrição é motivado por uma analogia da patologia do indivíduo com outra semelhante, ou por base fisiopatológica, que o médico acredite que possa vir a beneficiar o paciente. O uso off label é feito por conta e risco do médico que o prescreve.

A Lei nº 14.313, de 21 de março de 2022, que dispõe sobre os processos de incorporação de tecnologias ao SUS e sobre a utilização pelo SUS de medicamentos cuja indicação de uso seja distinta daquela aprovada no registro da ANVISA, desde que seu uso tenha sido recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), demonstradas as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança, e esteja padronizado em protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Excepcionalmente a ANVISA pode autorizar o uso de um medicamento para uma indicação que não conste em bula, conforme previsto no Artigo 21 do Decreto 8.077, de 14 de agosto de 2013. **Contudo, atualmente, não há autorização excepcional pela ANVISA para o uso off label do medicamento semaglutida para o tratamento da obesidade**". (Grifei).

Acrescenta-se que o referido fármaco não foi avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC. Desse modo, não integra nenhuma lista oficial de medicamentos (Componente Básico, Estratégico e Especializado) disponibilizados pelo SUS no âmbito do Município e do Estado do Rio de Janeiro.

Com efeito, para o tratamento da obesidade, o NAT-Jus destaca o seguinte:

"O tratamento do sobrepeso e obesidade no SUS é regulamentado pela Portaria SCTIE/MS Nº 53, de 11 de novembro de 2020, a qual aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Sobrepeso e Obesidade em Adultos, e envolve a atuação conjunta de diversos níveis de atenção e de apoio do SUS.

Tal PCDT preconiza o tratamento da obesidade a partir de medidas não medicamentosas, com ênfase na prática de atividades físicas, promoção de uma alimentação adequada e saudável e suporte psicológico. E, em casos específicos, pode ser indicada a realização de cirurgia bariátrica pelo SUS.

As ações da Linha de Cuidado de Sobrepeso e Obesidade (LCSO) contemplam atribuições dos componentes da Atenção Primária a Saúde (APS), da Atenção Especializada, dos sistemas de apoio e logísticos e do sistema de regulação. Pacientes com IMC < 40 kg/m² são direcionados para o atendimento e acompanhamento pela APS, enquanto pacientes com IMC ≥ 40 kg/m² ou ≥ 35 kg/m² com comorbidades são direcionados para o atendimento e acompanhamento pela Atenção Especializada.

Quanto ao quadro de obesidade, existe política pública no SUS que garante o atendimento integral aos indivíduos com tal condição. Destaca-se que, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, existe Serviço Especializado de Atenção a Obesidade, conforme Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde - CNES. O acesso aos serviços habilitados ocorre com a inserção da demanda junto ao sistema de regulação. Conforme documento médico (Evento 1, ANEXO3, Página 16), **o autor já se encontra em estabelecimento com Serviço de Atenção a Obesidade - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, onde deverá receber o atendimento integral e adequado para sua condição clínica**". (Grifei).

Pois bem.

Em relação à obrigatoriedade de fornecimento gratuito de insumos, não incluídos na listagem oficial do SUS, para tratamento da enfermidade do suplicante, é relevante a análise dos possíveis reflexos da decisão favorável à parte autora nas políticas públicas, já que não podem os recursos destinados aos programas de saúde serem distribuídos fora de um critério minimamente razoável, considerando-se o conjunto da população.

Importante ressaltar que não obstante ser a saúde direito de todos e dever do estado (art. 196 da CRFB/88), ele "é assegurado mediante políticas sociais e econômicas. Ou seja, não há um direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma política pública que o concretize."

In casu, a parte autora possui condição para a qual o SUS já disponibiliza programa específico e eficaz, de forma que não cabe ao Poder Judiciário impor à Administração adoção de políticas de saúde diversas daquelas preconizadas pela rede pública.

Ademais, como destacado mais acima, o autor já realiza acompanhamento em Serviço de Atenção a Obesidade, junto ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, evidenciando, assim, sua devida regulação pelo SUS.

Na hipótese dos autos, ressalto que o próprio documento médico apresentado pela parte autora não consigna urgência no tratamento ou agravamento do quadro clínico e risco de vida.

Nesse contexto, tendo em vista as informações apresentadas pelo Núcleo em seu parecer, verifico que não restou demonstrada a imprescindibilidade do insumo vindicado, tampouco a ineficácia das opções terapêuticas previstas no SUS.

Com efeito, a improcedência do pleito é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

*Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO**, conforme fundamentação supra.*

(...)"

O Recurso interposto sustenta que as opções existentes no SUS foram usadas e não foram eficazes, o medicamento pleiteado SEMAGLUTIDA tem registro e uso aprovado pela ANVISA para o tratamento da patologia do Recorrente ainda, que buscou o Poder Judiciário diante da impossibilidade de arcar com o alto custo do medicamento.

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial e reiterado em sede recursal, tendo em vista a declaração firmada e a renda comprovada nos autos, em consonância com fundamento no Enunciado nº 119 das Turmas Recursais do Estado do Rio de Janeiro:

ENUNCIADO 119 - *"O pedido de gratuidade de justiça pode ser analisado pela Turma Recursal quando do conhecimento de recurso interposto sem preparo, desde que esteja acompanhado de declaração de hipossuficiência nos termos do art. 2º da Lei 1.060/50."* (Aprovado na Sessão Conjunta de 03/12/2013. Publicado no DJ-e de 18/12/2013, pg 1.363).

Esta 8ª Turma já analisou a questão de mérito ora discutida, tendo firmado entendimento no sentido de que em hipótese similar, o pleito autoral pode ser acolhido (a exemplo processo nº 5013887-54.2024.4.02.5101) e, seguindo os mesmos fundamentos, integro a decisão colegiada ao presente recurso, como razões de decidir:

"I - DO DIREITO À SAÚDE E O RE 855.178:

Considerando o julgamento, sob o crivo da repercussão geral, pelo STF no RE 855.178, que reafirmou que a solidariedade dos entes no fornecimento do tratamento adequado aos necessitados se insere no rol de deveres do Estado, passo a adotar tais premissas no julgamento dos recursos em face de sentença e agravo sobre o tema. Vejamos:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente." (STF , RE 855.178, Min Luiz Fux, Publicado em 16/3/2015)

Ficaram vencidos, no mérito, os Ministros Teori Zavascki, Roberto Barroso e Marco Aurélio.

Destaco que foi também reconhecida no STF repercussão geral no RE 566.471- RG, relatoria do Ministro Marco Aurélio, no qual se debate o dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave, que não possui condições financeiras para comprá-lo. Matéria que, em regra, ante a limitação de alçada do Juizado, encontra-se fora da competência deste.

Portanto, a discussão acerca da legitimidade passiva da União decidida em sede de repercussão geral deve ser adotada.

Destacou ainda o Ministro:

“O art. 200 da Constituição, que estabeleceu as competências do Sistema Único de Saúde (SUS), é regulamentado pelas Leis Federais 8.080/90 e 8.142/90. O SUS consiste no conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos e medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.”

“.....Bem delimitado o tema, verifica-se que o Tribunal de origem, ao assentar a responsabilidade solidária da União, “não destoou da jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte”, no julgamento da Suspensão de Segurança (SS) 3355, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. ...”

De acordo com o voto condutor, o direito à saúde é estabelecido pelo artigo 196 da Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

A jurisprudência atual do STF, sobre o tema, também tem registrado questão da possibilidade de substituição do medicamento/cirurgia pretendido(a) por alternativa padronizada. E, sobre o tema, trago à baila recente decisão do STF que suspende decisão judicial que determinava a realização de cirurgia sem demonstração de necessidade e ineficácia de alternativas. Vejamos:

“Quinta-feira, 08 de janeiro de 2015

Custeio de cirurgia exige demonstração de necessidade e ineficácia de outras alternativas

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewandowski, determinou a suspensão de decisão do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL) que havia obrigado o Município de Maceió a custear procedimento médico conhecido como artroscopia, no valor de R\$ 41 mil. Segundo o ministro, desde decisão anterior da Corte em caso semelhante, entendeu-se que não ficou demonstrada a necessidade de realização do procedimento médico nem a busca por alternativas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Para o ministro Ricardo Lewandowski, a decisão da Justiça local representa uma ameaça de grave lesão à ordem e à economia públicas. Ao decidir, o presidente do STF relatou que o caso questionado pelo município se amolda a decisão anterior do STF, já proferida na própria Suspensão de Tutela Antecipada (STA) 748, e determinou a extensão de seus efeitos ao novo caso enfrentado pela administração da capital de Alagoas.

O tema em debate na decisão original da STA 748 é análogo ao veiculado no pedido atual do município. “Os princípios da economicidade e da eficiência justificam o acolhimento do pleito ora formulado pelo Município de Maceió”, afirmou o ministro Lewandowski, deferindo sua extensão para a suspender os efeitos de decisão proferida pelo TJ-AL, a qual havia mantido o bloqueio de R\$ 41.396,59, determinado pelo juízo da 14ª Vara Cível de Maceió para garantir a realização da cirurgia.

Pedido de extensão

O Município de Maceió argumentou em seu pedido de extensão de decisão que, semelhantemente ao caso original, não houve a demonstração de necessidade de realização de uma cirurgia de artroscopia de ombro em detrimento de outros tratamentos fornecidos pelo sistema público. No caso original decidido pelo STF (STA 748), também relativo àquela municipalidade, foi determinada a suspensão de ordem judicial que determinava a realização de um procedimento de estimulação magnética transcraniana em um outro paciente, ao custo de R\$ 68 mil. Segundo o entendimento da presidência do Supremo à época, as provas não confirmaram o caráter urgente do procedimento nem evidenciaram a busca prévia por alternativas oferecidas pelo SUS.”

II - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO - REPETITIVO STJ 1.657.156/RJ - MODULAÇÃO DE EFEITOS.

O STJ, no julgamento do recurso repetitivo nº 1.657.156/RJ, fixou a tese da possibilidade de concessão de medicamentos não padronizados no SUS desde que sejam comprovados, cumulativamente, os seguintes requisitos:

- (i) a necessidade do medicamento ou a ineficácia da alternativa terapêutica existente no SUS;*
- (ii) a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento; e*
- (iii) a existência de registro na ANVISA do medicamento.*

Confira-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glauco 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.

2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.

3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106).

Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

Em sede de embargos de declaração houve a complementação do julgado acima com esclarecimentos e a modulação de efeitos. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. VEDAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO OFF LABEL.

1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

2. Não cabe ao STJ definir os elementos constantes do laudo médico a ser apresentado pela parte autora. Incumbe ao julgador nas instâncias ordinárias, no caso concreto, verificar se as informações constantes do laudo médico são suficientes à formação de seu convencimento. 3. Da mesma forma, cabe ao julgador avaliar, a partir dos elementos de prova juntados pelas partes, a alegada ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS decidindo se, com a utilização do medicamento pedido, poderá haver ou não uma melhoria na resposta terapêutica que justifique a concessão do medicamento. 4. A pretensão de inserir requisito diverso dos fixados no acórdão embargado para a concessão de medicamento não é possível na via dos aclaratórios, pois revela-se como mero inconformismo e busca de rejugamento da matéria. 5. No caso dos autos, faz-se necessário tão somente esclarecer que o requisito do registro na ANVISA afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso off label, salvo caso autorizado pela ANVISA. 6. **Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, para esclarecer que onde se lê: "existência de registro na ANVISA do medicamento", leia-se: "existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".**

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. UNIÃO. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO.

1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

2. No caso dos autos, não há vício a ensejar a modificação do que foi decidido no julgado.

3. Todavia, tendo em vista as indagações do embargante, é necessário fazer os seguintes esclarecimentos: (a) o laudo médico apresentado pela parte não vincula o julgador, isto é, cabe ao juiz avaliar o laudo e verificar se as informações constantes nele são suficientes para a formação de seu convencimento quanto à imprescindibilidade do medicamento; (b) a exortação constante no acórdão embargado para que o juiz, após o trânsito em julgado, expeça comunicação ao Ministério da Saúde e/ou CONITEC a fim de realizar estudos quanto à viabilidade de incorporação no SUS do medicamento deferido, deve receber o mesmo tratamento da situação prevista no § 4º do art. 15 do Decreto n. 7.646/2011. 4. **Necessário, ainda, realizar os seguintes esclarecimentos, agora quanto à modulação dos efeitos: (a) os requisitos cumulativos estabelecidos são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018; (b) quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior à 4/5/2018, é exigível o requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento.** 5. Embargos de declaração rejeitados.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PARTE AUTORA. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

2. No caso dos autos, não há vício a ensejar a integração do que decidido no julgado, pois, não constitui omissão o mero inconformismo com a conclusão do julgado, manifestado nas seguintes afirmações: que o STF tem admitido o fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA; que a questão está sendo apreciada, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, mas que ainda não foi concluído o julgamento; que o requisito de registro na ANVISA fere o princípio da isonomia. 3. Embargos de declaração rejeitados.

PROCESSUAL CIVIL. ART. 494, I, DO CPC/2015. CORREÇÃO DE INEXATIDÃO MATERIAL. **ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO REPETITIVO.**

1. O inciso I do art. 494 do CPC/2015 possibilita ao julgador a correção de ofício de eventuais inexatidões materiais no decisum. 2. No caso dos autos, a fim de evitar dúvidas, impõe-se a alteração do termo inicial da modulação dos efeitos. 3. Ante o exposto, de ofício, altera-se o termo inicial da modulação dos efeitos, do presente recurso especial repetitivo, para a data da publicação do acórdão embargado (4/5/2018).

TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.

(EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018)

O esclarecimento se deu em relação ao terceiro requisito, registro na ANVISA, a fim de que ficasse claro que tal registro compreendesse a observância dos usos autorizados pela agência.

Desse modo, o fornecimento de medicamento em uso off label não está abarcado pelo entendimento do STJ.

Com relação à modulação de efeitos para os processos distribuídos até 03/05/2018 não é necessária a observância dos requisitos definidos pelo repetitivo, mas somente a demonstração da imprescindibilidade do medicamento.

III - MEDICAMENTOS EXPERIMENTAIS E/OU SEM REGISTRO NA ANVISA - STF RE 657718

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 657718, em sede de repercussão geral, em 22/05/2019, fixou a seguinte tese no tocante ao fornecimento de medicamentos experimentais ou sem registro na ANVISA:

"O Plenário, por maioria de votos, fixou a seguinte tese para efeito de aplicação da repercussão geral:

1) O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.

2) A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.

3) É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos:

I - a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras;

II - a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior;

III - a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.

4) As ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser necessariamente propostas em face da União."

Pois, o registro na ANVISA constitui proteção à saúde pública, atesta a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país e garante o devido controle de preços. O registro sanitário por agência estatal é ferramenta que garante a proteção à saúde pública ponderando interesses de empresas farmacêuticas, pesquisadores, médicos e pacientes na aceção individual e coletiva (saúde pública).

Outrossim, no caso de medicamentos experimentais, ou seja, sem comprovação científica de eficácia e segurança não deve o Poder Judiciário determinar o fornecimento. Pois, se por um lado há o direito à saúde, o Estado de forma responsável sem substrato em pesquisas quanto à segurança e eficácia, não deve concluir pelo direito ao fornecimento.

Contudo, no caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, ainda que não exista registro na ANVISA, a questão tem outros contornos, sendo possível o fornecimento judicial em caráter absolutamente excepcional, o qual pressupõe irrazoável mora da ANVISA em apreciar o pedido e comprovação dos itens I, II e III acima.

Por fim, para melhor delineamento do julgado, destaco que se tratava de pleito de fornecimento de medicamento que à época, em 2010, não possuía registro na ANVISA, mas já tinha registro na Food and Drug Administration - FDA e na European Agency for the Evaluation of Medical Administration - EMEA. Em 2014, o medicamento obteve registro na ANVISA e, atualmente, encontra-se com o fornecimento incorporado no âmbito do SUS. Portanto, quadro diverso de medicamento sem eficácia comprovada ou com negativa de registro na ANVISA, mas sim de verdadeira e irrazoável mora da agência na análise dos pedidos de registro.

IV - DO CASO CONCRETO:

A parte autora é portadora de diabetes melitus tipo 2 e obesidade sem controle adequado, entre outras comorbidades.

Requer o uso de Ozempic para perda de peso (evento 1, ANEXO2 pag. 17):

(...)

Pois bem.

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo nº 1.657.156/RJ, fixou a tese da possibilidade de concessão de medicamentos não padronizados no SUS desde que comprovados, cumulativamente, os seguintes requisitos:

(i) necessidade do medicamento ou a ineficácia da alternativa terapêutica existente no SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Ao que se verifica do julgado já mencionado neste voto, o medicamento em uso off label não está abarcado pelo entendimento do STJ.

Nesse sentido também o Enunciado 75 do CNJ:

ENUNCIADO Nº 75 Nas ações individuais que buscam o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS, sob pena de indeferimento do pedido, devem ser observados cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo STJ, no julgamento do RESP n. 1.657.156, e, ainda, os seguintes critérios:

I) o laudo médico que ateste a imprescindibilidade do medicamento postulado poderá ser infirmado através da apresentação de notas técnicas, pareceres ou outros documentos congêneres e da produção de prova pericial;

II) a impossibilidade de fornecimento de medicamento para uso off label ou experimental, salvo se houver autorização da ANVISA;

III) os pressupostos previstos neste enunciado se aplicam a quaisquer pedidos de tratamentos de saúde não previstos em políticas públicas. (grifos nossos)

(...)

O CONITEC publicou artigo sobre o uso off label, no qual destaca:

"Além da falta de evidências que explicam por que um medicamento não está registrado no País ou não possui determinada indicação em sua bula, há motivos econômicos muito importantes.

Solicitar a autorização de registro de um medicamento é prerrogativa da empresa produtora. Uma empresa pode desistir de fazê-lo por razões comerciais que vão desde a falta de interesse nesse mercado até acordos entre as empresas compartilhando os nichos de mercado e reduzindo assim a concorrência.

Sob essa ótica, há que se rever a utilização do termo e desmistificar o uso off label, que é muito mais comum do que se imagina ou se registra: o termo deveria ser aplicado apenas para o uso irrestrito e inseguro, quando não há evidências científicas. Quando a ausência de registro se deve a razões de mercado, a incorporação ou prescrição poderá ser feita, desde que cientificamente embasada." (grifos nossos)

Desse modo, possuindo o fármaco registro na ANVISA e existindo evidências científicas que embasem a sua prescrição para a doença que acomete a parte autora, possível o fornecimento pelo Poder Público.

Nesse sentido o enunciado 59 do CNJ:

ENUNCIADO Nº 59 As demandas por procedimentos, medicamentos, próteses, órteses e materiais especiais, fora das listas oficiais, devem estar fundadas na Medicina Baseada em Evidências - MBE.

Na hipótese dos autos, o parecer do NAT corrobora a existência de evidência científica para o uso da semaglutida, que foi prescrita por serviço especializado de atenção a obesidade do SUS.

Quanto à imprescindibilidade do medicamento, observa-se que, de acordo com o formulário juntado aos autos, a médica assistente informou que os tratamentos até então realizados não tiveram sucesso e que a Autora perder peso.

Quanto ao tema 793 do STF, vejamos o entendimento vigente na 8ª Turma:

"SAÚDE - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ENTE PÚBLICO, COM BASE NA TESE 793 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Em recurso onde ente federado alega ilegitimidade passiva, com fulcro na Tese 793 do Supremo Tribunal Federal, alegando que a atribuição de fornecer medicamento/tratamento é de outro ente federado, vale dizer, a interpretação mais consentânea com a jurisprudência do STF é a de que os cidadãos podem postular a concessão de tais medicamentos de todos os órgãos federados, sendo todos legítimos para a causa, porque fazem parte da relação jurídico-material primária, por força da Constituição Federal, sendo ainda, solidariamente responsáveis, com base no mesmo diploma. O que diz o tema 793 do Supremo Tribunal Federal é que o juiz do cumprimento da sentença irá direcionar o ofício para o devedor principal, em primeiro lugar. Assim, a discussão é se o ente federado é o devedor principal ou não, ou seja, aquele que será oficiado em primeiro lugar para cumprir a obrigação. 8 TR - Sessão de 11/06/2019 - Relator: LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA - Processo: 0190958222017402515102"

Nesse sentido o enunciado 60 do CNJ:

"A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento"

Observa-se que logo após a concessão da tutela provisória no Evento 14, o Estado do Rio de Janeiro informou possuir o medicamento em estoque, orientando a parte autora a comparecer com receituário atualizado para sua retirada (evento 27, OFIC1).

Por fim, ressalto que, sendo a responsabilidade solidária entre os entes, possível a repartição pro rata dos custos como requerido. Contudo, tal deve ser efetivado após fornecimento. Pois, a compensação entre os entes não deve, em hipótese alguma, prejudicar o fornecimento.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação, **VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos.** Condene os recorrentes vencidos em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação ou, na inexistência de provimento condenatório, em 10% sobre o valor da causa. Publique-se. Intimem-se. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juízo de origem."

No caso dos autos, a hipótese em análise é idêntica ao julgado transcrito, alterando-se apenas os pólos do recurso, dado que no presente caso a sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial, sendo necessário reformá-la, mas sob os mesmos argumentos desenvolvidos no precedente supracitado.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido de caráter definitivo e determinar que as Rés, solidariamente, conforme suas respectivas atribuições fixadas pelo SUS (Tema 793 do STF e Lei nº 8.080/90), forneçam à parte autora a medicação SEMAGLUTIDA, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 60 (trinta) dias a contar da intimação desta decisão, de forma contínua e

ininterrupta, observando-se o que se segue: (i) A medicação em questão deverá ser entregue em local a ser indicado pelos réus, dentro do prazo para cumprimento, a fim de que a parte autora ou seu representante legal possam nele comparecer, para procederem à retirada da medicação requisitada. (ii) A entrega à parte autora da referida medicação, em qualquer hipótese, deverá ser necessariamente confirmada pelos réus, nos autos, sob pena de se entender sua omissão como descumprimento desta sentença e conseqüente sequestro de verba pública para aquisição da mesma. (iii) Determino, ainda, que a parte autora apresente requerimento com nova prescrição médica, quando da necessidade de reposição dos medicamentos fornecidos ou de troca de medicação, bem como que informe, em nome da lealdade processual, caso não necessite mais da medicação aqui requerida. Deverá, também, informar nestes autos eventual mudança de endereço. (iv) Nesse sentido, destaque-se que, sempre que for requerido pelos réus, deverá a parte autora apresentar-lhes, diretamente nos órgãos de execução do fornecimento da medicação em apreço, receituário atualizado e demais dados e documentos que se mostrarem necessários, a fim de que os réus procedam ao controle do fornecimento ora deferido. Sem custas e honorários. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.